把健康放回日常生活

中国成年人健康价值观与日常实践的循证论述

2026年11月12日 · 正式图文版



情境插画 / AI生成，非真实人物或病例

摘要

健康知识的价值，需要通过日常选择、可用时间与支持条件才能进入生活。本文采用定向叙述性证据综合，结合中国健康素养文件、食品营养标签标准、国际指南和代表性随机试验，讨论普通成年人如何将身体、心理和关系需要纳入日程。

本文提出以能力、机会和动机诊断障碍，以具体场景组织行动，并将中断后的恢复与参与负担纳入评价。四个生活案例分别回应工作久坐、外卖选择、晚间拖延及家庭照护。案例和日程为作者设计的教学情景，不是受试者资料；组合方案的长期效果尚未经过验证。

核心论点

健康具有自身价值。可持续实践需要个人行动，也需要家庭、单位与公共环境提供条件。评价改变时，应共同关注身体功能、心理福祉、关系质量和现实负担。

关键词：健康素养；生活方式；行为改变；心理健康；时间成本；健康公平

02–04 理解证据与行动条件

05–08 走进四个日常场景

09–11 形成可持续的实践与评价

12–13 核对来源与证据边界



知识在进步 行动仍需要条件

对熬夜、久坐和饮食失衡的担忧，应该转化为可以检验的问题。国家卫生健康委监测显示，2025年居民健康素养水平为33.69%，较2024年提高1.82个百分点；调查对象为15—69岁常住人口，有效问卷70451份。[1]

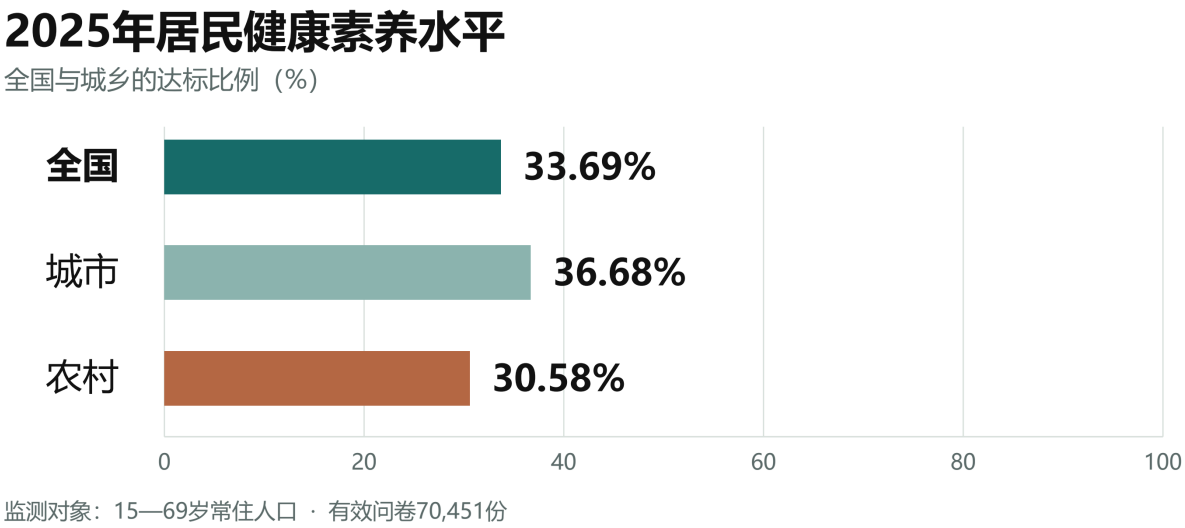


图1 2025年中国居民健康素养水平。来源：国家卫生健康委监测、山西省卫健委完整转载。[1] 三组为同年同一指标；全国值是全国估计，不是城市与农村的简单平均。未显示置信区间，因为本次引用的公布页未提供。

这个比例不代表什么

33.69%不能解释为“只有约三分之一的人生活健康”，其补数也不是“不健康人群比例”。健康素养包括获取、理解和运用信息的能力，不能替代实际饮食、睡眠或活动的测量。城市与农村之间的差异，也不能单独证明某个因素导致了差距。

WHO依据2022年的全球成人资料报告，约31%的成年人身体活动不足，较2010年增加约5个百分点。[2] 这是另一人群、另一指标。两组数字不宜拼成“知道却做不到”的人数估计，却共同提醒我们：认知进步与行为改善需要分别观察。

本文的研究问题

怎样让有依据的健康行为，在工作、学习、家庭照护和有限预算中更容易开始、维持与恢复？

有效干预需要落实到具体条件

生活方式可以改变某些健康结局，但证据有适用边界。美国糖尿病预防项目发现，对血糖升高且超重的高风险成年人，强化生活方式干预降低了随访期内糖尿病的发生。干预包含个别化课程和后续支持，不能把研究效果简化为“多一点自律”。[5]

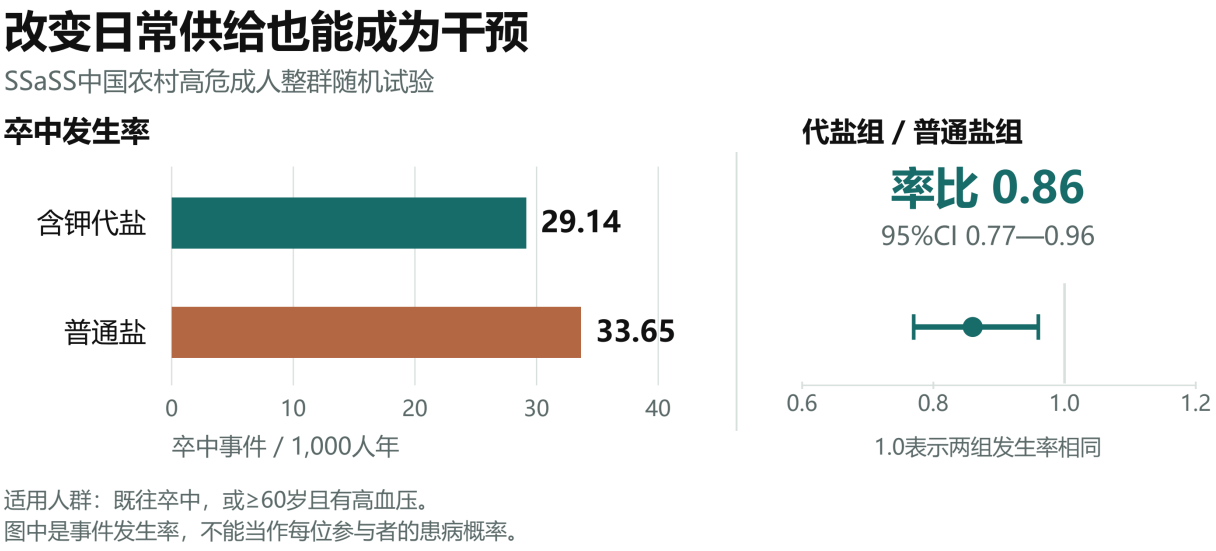


图2 SSaSS整群随机试验中的卒中发生率与率比。来源：Neal等，2021，原始研究摘要。[6] 研究纳入中国农村20995人，平均随访4.74年；对象为有卒中史，或≥60岁且有高血压者。

怎样读懂这张图

每1000人年是把随访时间纳入分母后的发生率单位，不等于“每1000人一定有多少人发病”。率比0.86的95%置信区间为0.77—0.96，反映的是两组发生率的相对比较。不能据此给一名普通年轻人计算个人获益。

该试验把改变落实到日常食盐的供给和使用。它支持这一特定干预在人群中的效果，却未验证本文全部生活方案；也不意味着所有人都适合自行使用含钾代盐。存在相关疾病或用药问题者，需要专业评估。

对日常生活的启示

除了告诉自己“应该怎样”，还要安排“怎样做到”：食物如何获得、活动何时发生、睡眠机会由谁保护、困难出现后找谁支持。

先辨认障碍 再选择行动

COM-B框架把行为与能力、机会和动机联系起来。[4] 它适合帮助定位障碍，本身并不证明某个生活方案有效。中国健康素养指导也将身体、心理和社会适应纳入健康观。[3] 本文据此主张，把健康看作值得维护的生活能力，而不只是一组绩效数字。

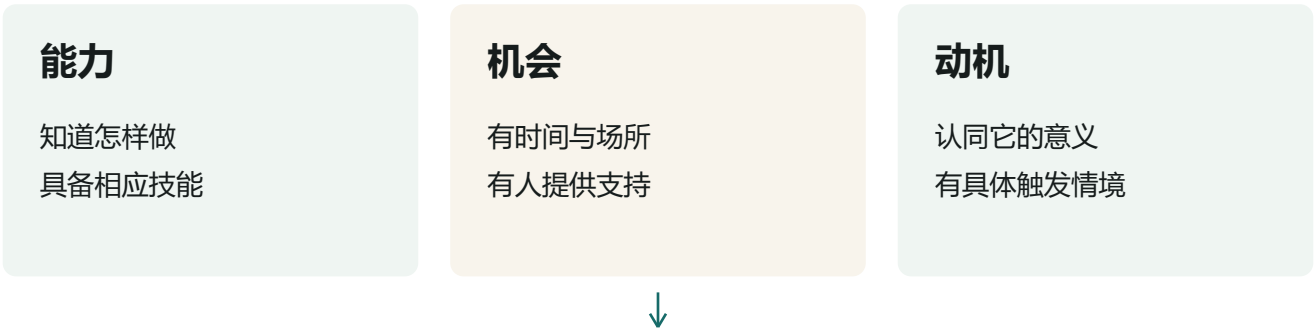


图3 依COM-B整理的行动诊断示意。[4] 箭头用于展示本文的讨论顺序，并非已验证的单向因果模型。

发生了什么	先检查什么	可尝试的改变
下班后总没运动	是否还有安全空间、时间与精力	把一段通勤改成步行，或调整家务分工
知道应少盐却难执行	是否会看标签，酱汁是否可单独放	先学一次换算，再改变一个常用选择
计划很完整却持续不了	行动是否过大，是否有明确触发点	缩小起点，明确下一次何时做

健康价值观如何进入一次决定

当日程冲突时，把“今晚是否还有恢复时间”列为决策条件；当感到疲惫时，允许调整任务；当出现持续困扰时，把求助视为维护生活能力的行动。这些是本文的规范主张，不是对个人道德的评分。

经济视角还要求看见时间成本：采购、烹饪、通勤和照护都占用资源。一项行动值得尝试，仍需确认谁付出时间、谁获得便利，以及是否把额外劳动集中给同一位家庭成员。

从连续开会到有活动的工作日

教学情景 非真实病例

小林上午连续开会，午饭在电脑前吃，下午又要写报告。他决定先保护午间的一次短步行，而不是立刻给自己安排每天一小时健身。

把笼统目标改成三个明确动作

1. **找到事件**

   把“午餐结束”作为提示；先选熟悉、安全、能随时返回的路线。起步可试10分钟，这是行动示例。

2. **区分两类活动**

   会议间隙起身取水有助于减少连续坐着的时间；达到中等强度的快走，才按相应强度计入有氧活动。二者不能混为一项。

3. **准备替代**

   下雨时改走室内安全通道；午间临时有事，就把行动移到下班后可行的一段路。条件不允许时缩小或顺延。

上午	午间	下午	下班
会议结束后活动一下	饭后短步行	换任务时离开座位	选择一段可步行路线

图4 工作日活动节点示意。以上安排为作者设计，没有统一医学规定要求每隔多少分钟起身。

WHO建议18—64岁成人每周150—300分钟中等强度或75—150分钟高强度有氧活动，或等效组合，并每周至少2天肌肉强化。[7] 这是逐步靠近的方向，初始10分钟不是完整推荐量。CDC提供的粗略强度判断是：中等强度时通常还能交谈，但难以唱歌；这不是个体化运动测试。[18]

可直接使用的话术

“我午饭后出去走一小段，回来再看消息。” 学习时，可把提示设为“下课”或“写完一段文字”，无须照搬工作日安排。

05 生活场景二

一份外卖与一包酱汁的选择



图5 日常餐食搭配插图。AI生成的教学示意；不代表精确份量、热量或真实品牌。

教学情景 非实际膳食调查

小陈中午只能点外卖。他先在现有预算内找主食、蔬菜与鱼肉蛋豆类的组合，再备注酱汁分装。少油少盐、食物多样是膳食指南方向；这份示例不是个人减重餐。[10]

看标签时 多做一步“实际用量”换算

虚拟调味料标签	钠含量	按2000mg钠NRV计算
每100克	3000毫克	150%
实际用10克	300毫克	15%
实际用20克	600毫克	30%

计算：3000毫克 × 10克 ÷ 100克 = 300毫克。表内产品及含量完全是假设，演示按标签基准换算；不是市场测量数据。GB 28050—2011规定营养成分的表达方式及钠的营养素参考值。[11] NRV%是标签参考值比例，不是个人当日“还能吃多少”的配额。

WHO一般成人建议为每天钠摄入少于2000毫克，相当于盐少于5克，包含全部来源。[19] 标签中的钠还可能来自其他含钠配料，不能只数自己撒了几勺盐。2025版营养标签国标将于2027年3月16日实施；本文写作时尚未到该日期。[12]

下一次点餐的一个动作

只改一个重复选择：例如酱汁另放、增加一份能负担的蔬菜，或把含糖饮料换成水。先检查可行性，不要求每餐逐克计算。

晚间收尾 从还想刷一会儿开始

教学情景 非睡眠诊断

小周第二天需要起床上班，但夜里仍想通过刷视频获得属于自己的时间。若直接要求“十点必须睡”，就忽略了他想放松的需要，也没有处理尚未结束的工作。

同时安排放松和收尾

先把当天需要完成的事写清楚，将可顺延的事安排到下一次；为自己选择一种愿意重复的放松活动，再给手机通知和充电位置设定边界。这里的目标是保护睡眠机会，不能把“马上睡着”变成必须完成的任务。

21:45
收尾并记下待办

22:00
选择安静的放松

22:30
开始洗漱与准备

23:00
进入睡眠机会

图6 假设次日7:00起床的一种晚间安排；不是统一作息处方。23:00至7:00为8小时机会窗口，实际睡眠还受入睡与夜间觉醒影响。

国内2025年睡眠健康核心信息给出一般成年人7—8小时参考，并承认个体差异；AASM/SRS共识对18—60岁成人建议规律地每晚至少7小时。睡眠还应看质量、规律性和白天功能，不能只追逐某个小时数。[8,9]

主要障碍	优先讨论的内容
下班过晚或轮班	结合班次保护睡眠机会，协商可预测的休息；不套用统一早起时间
照护任务不断打断	讨论谁承担哪段照护，以及能否获得可持续替代支持
有机会仍长期睡不好	若影响日常生活，尽早寻求专业评估，而非反复加大自我要求

例如可以说：“我准备结束今天的工作，明早再处理这件不紧急的事。” 对持续失眠、明显日间困倦或其他睡眠异常，生活安排不能替代必要诊疗。[8]

让照护分工留出恢复的空间

教学情景 非家庭观察数据

一对双职工伴侣晚饭后要收拾厨房、照顾孩子和准备第二天用品。若把“锻炼与放松”额外加给其中一人，计划就会与已经拥挤的晚上冲突。

先把隐形任务写出来

今晚的任务	本次协商的承担者	明确完成边界
洗碗与整理台面	伴侣甲	做到厨房收尾，不延伸成全屋清洁
陪伴孩子与准备用品	伴侣乙	确认必要事项，避免临时新增任务
一段个人恢复时间	双方轮流获得	由另一方接手当时必要的照护

这个分工只是讨论模板。单亲家庭、照顾失能长者或支持不足的人，不能被要求复制它；下一步可能是寻找亲友、社区或专业服务，而非再挤压自己的睡眠。评估成本时，要把无酬劳动和协调时间一起考虑。

把需要说得可以回应

“我今天有些疲惫，希望有一小段安静时间。你能先接手收拾吗？明天我们再交换。” 也可以先问对方希望被倾听，还是一起商量办法。

WHO的社会连接框架同时关注关系结构、支持功能和互动质量。[14] 因此，联系人数不是唯一指标；能否表达需要、获得帮助，以及关系是否安全，具有实际意义。独处与孤独也应区分。

工作环境同样需要参与。WHO工作场所心理健康指南覆盖组织干预、管理者与员工培训、个人支持以及返岗安排。[16] 个人可以尝试表达边界，组织则应讨论工作安排与支持条件，不能用情绪管理课程替代所有工作问题。

如果困扰持续、加重或影响日常功能，应寻求专业评估。亲友支持和自我调整有其位置，也需要知道何时获得进一步帮助。[3]

把150分钟放进一张真实日历

下面示范一位身体条件允许、已能耐受相应活动的成年人如何分配中等强度有氧活动。它是算术与日程示例，不是初学者必须立刻完成的训练计划；每个人还需要根据能力、疾病、通勤与照护条件调整。

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
30 分钟 中等强度 有氧活动	30 分钟 中等强度 有氧活动	30 分钟 中等强度 有氧活动	30 分钟 中等强度 有氧活动	30 分钟 中等强度 有氧活动	弹性 休息或 合适的活动	弹性 休息或 合适的活动

30分钟 × 5天 = 150分钟

示例另在周二、周六安排适合自己的肌肉强化活动。

图7 作者设计的一周活动示例。仅把达到相应强度的有氧活动计入150分钟；肌肉强化另作安排，图中不以其时长替代有氧分钟。[7]

三种生活情况 三种改法

现实情况	可尝试的安排	观察什么
每天时间碎片化	把部分30分钟分成几段较短活动	是否达到所需强度，是否能安全重复
某天临时加班	移到下一段可行时间，或先保留较少活动	是否过度补偿，是否牺牲睡眠
刚开始或体能下降	从更少、更轻的活动开始逐步增加	身体感受、耐受与后续恢复

WHO强调少量活动也有价值，且应限制久坐。[7] 因而可以同时记录“有没有增加活动”和“累计多少相应强度活动”，而不把未达到目标的一周归零。对于需要适配的慢病、孕期或功能限制，应选择对应建议并获得必要指导。

一个更诚实的周末问题

这个安排是否让日子更有活动，也仍然容得下工作、休息和关系？如果没有，下一周先改变安排条件，而不是直接加码。

十二周用来观察 而不是证明毅力

习惯形成研究显示，在稳定情境重复行为时，自动化过程存在明显差异；该研究不支持所有人必须在21天或66天后达标。[15] 以下十二周安排是本文提出的观察方案，未经过临床验证，也不代表习惯形成期限。

阶段	主要任务	继续或调整的依据
第1–2周	观察3–7天；选一个优先行动	是否能做，是否有明确情境
第3–4周	减少准备步骤；协调一个现实障碍	是否比开始时更容易
第5–8周	合适时渐进增加；必要时保持原量	精力、情绪、负担与耐受
第9–12周	观察忙碌日如何调整和恢复	哪些做法值得长期保留

每周一次简短记录

先选择方便的时间，例如周日晚上约10分钟。这个频次和时长只是安排建议。记录应当帮助理解生活；如果记录本身造成负担，可以减少项目。

我本周选择的行动

实际完成情况与感受

最主要的现实障碍

下周减少的一个阻力

需要的帮助与下一次机会

中断后，选择下一次可行机会重新开始，不用过量运动、补偿性节食或牺牲睡眠“还债”。本文建议同时观察重启是否容易；这一指标是实施提案，尚不能宣称能预测长期健康结局。

成功也包括调整

如果任务太大，就缩小；如果条件受限，就寻找支持；如果出现持续不适或功能受影响，就寻求专业帮助。记录不用于给自己或别人贴标签。

生活质量与公平应共同进入评价

健康具有自身价值。把休息、情绪和关系纳入安排，并不需要先证明它们能够提高工作产出。大众化健康理念应提供共同方向，也应允许年龄、疾病、残障、收入和照护条件带来的差异。

评价效果 也评价谁承担成本

若把本文框架推广到社区或单位，应比较具体干预与现有做法，预先确定主要结局，记录参与率、维持情况、心理福祉、不良体验和时间负担。不能用一个未经验证的“健康总分”替代这些信息，也不应要求员工公开个人心理记录。

经济评价应区分成本有效、节省支出和预算可承受。可参照CHEERS 2022报告视角、成本、健康结果及不确定性；预算影响分析需另外设计。[17] 同一段时间损失不能被重复计入多个成本项目，家庭无酬劳动也不宜从账本中消失。

本文的证据范围

检索截至2026年11月12日，优先使用中国官方文件、WHO资料与原始论文，属于定向叙述性综合，未实施预注册系统综述或原创临床试验。特定高危人群试验不能直接预测普通成年人的收益，本文场景化组合方案仍需验证。部分来源仅取得官方概览或原始摘要，具体范围见参考资料。

生活方式也不是健康服务的全部。疫苗、按风险选择的筛查、科学就医及遵医嘱用药，仍需结合个人情况安排。[3] 不吸烟、避免二手烟暴露及获得专业戒烟支持值得纳入长期计划；不应为养生开始饮酒，低水平饮酒也可能带来健康风险。[3,13]

结论

可持续的健康生活，需要把知识落到具体选择，把行动放入现实时间，把恢复视为生活的一部分。个人愿意尝试与环境提供条件可以共同推进；其成效应由健康、福祉和公平的实际改善检验。

可追溯的证据来源

正文数字引用与下列序号对应。检索与访问日期统一为2026年11月12日。链接可点击打开；引用官方概览或原始摘要时，不表示已通读整份指南或论文全文。

[1] 国家卫生健康委员会. 2025年全国居民健康素养水平达到33.69%. 2026.

政府完整转载。 原文与访问记录 ↗

[2] World Health Organization. Physical activity. 2026.

全文；成人数据所对应年度为2022。 原文与访问记录 ↗

[3] 国家卫生健康委办公厅. 中国公民健康素养——基本知识与技能（2024年版）. 2024.

政府完整转载。 原文与访问记录 ↗

[4] Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. 2011.

出版商全文；Implementation Science.6:42；DOI: 10.1186/1748-5908-6-42。 原文与访问记录 ↗

[5] Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or Metformin. 2002.

PMC作者稿全文；N Engl J Med.346(6):393–403；DOI: 10.1056/NEJMoa012512。 原文与访问记录 ↗

[6] Neal B, Wu Y, Feng X, et al. Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. 2021.

PubMed原始摘要及元数据，未获得NEJM全文；N Engl J Med.385(12):1067–1077；DOI: 10.1056/NEJMoa2105675。 原文与访问记录 ↗

[7] World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. 2020.

NCBI Bookshelf托管原文。 原文与访问记录 ↗

[8] 全国爱卫办. 睡眠健康核心信息及释义. 2025.

福建卫健委完整转载。 原文与访问记录 ↗

[9] Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult: A Joint Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. 2015.

学会原始PDF；J Clin Sleep Med.11(6):591–592；DOI: 10.5664/jcsm.4758。 原文与访问记录 ↗

[10] 中国营养学会. 中国居民膳食指南（2022）. 2022.

官方解读全文；学会原网页直接读取失败。 原文与访问记录 ↗

可追溯的证据来源

[11] 中华人民共和国卫生部. GB 28050—2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则. 2011.

官方14页PDF。 原文与访问记录 ↗

[12] 芜湖市市场监督管理局. 鸠江区市场监管局沈巷市场监管所召开网络食品销售经营者落实食品安全主体责任培训会. 2026.

原始监管报告；仅核实施日期，未取得2025标准全文。 原文与访问记录 ↗

[13] World Health Organization. Alcohol. 2024.

2024-06-28事实表全文。 原文与访问记录 ↗

[14] World Health Organization. Social connection. 2025.

2025-06-30官方问答全文。 原文与访问记录 ↗

[15] Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J. How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. 2010.

摘要，未取得付费全文；Eur J Soc Psychol.40(6):998–1009；2009在线先发；DOI: 10.1002/ejsp.674。 原文与访问记录 ↗

[16] World Health Organization. WHO guidelines on mental health at work. 2022.

官方出版页概览，未逐条审读134页指南。 原文与访问记录 ↗

[17] Husereau D, Drummond M, Augustovski F, et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement: updated reporting guidance for health economic evaluations. 2022.

PMC全文；BMJ.376:e067975；DOI: 10.1136/bmj-2021-067975。 原文与访问记录 ↗

[18] Centers for Disease Control and Prevention. How to Measure Physical Activity Intensity. 2025.

官方页面；2025-12-04更新，Talk Test段。 原文与访问记录 ↗

[19] World Health Organization. Sodium reduction. 2026.

官方事实表；2026-05-11更新，成人推荐与钠盐换算。 原文与访问记录 ↗

编写与图像说明

本文采用公开资料的叙述性综合，没有原创受试者数据。四个案例、标签算例与日程均为教学设计。两张情境插图由内置图像生成工具制作，数据图由原始公布值绘制；图标用于导航。文稿与证据经过AI辅助整理和复核，未经期刊同行评审。作者身份、署名及投稿声明需由实际作者确认。

AI辅助方法来源：Kassis T, et al. Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents. 2026. arXiv:2609.00065。此项为写作方法说明，不支持本文健康结论。